

CHU de Tizi-Ouzou
Service de Médecine Interne
Pr SALAH MANSOUR

Université Mouloud Mammeri
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Module : Maladies systémiques
6eme année Médecine

Granulomatoses systémiques

Présenté par :
Dr H. Benazzoug

Introduction :

- Les granulomatoses :
 - Regroupent un ensemble de pathologies
 - Définies par la présence de lésions histologiques caractéristiques liées au recrutement de
 - macrophages
 - lymphocytes.

Définition :

Granulomatose : histologique

Caractère systémique :

- Touche au moins 2 organes

Intérêt de la question :

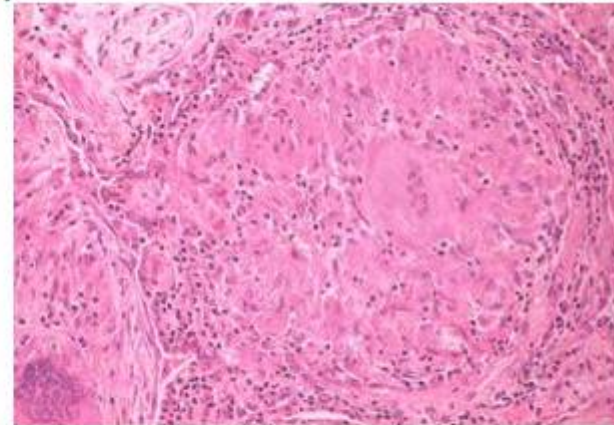
- Pathologies rares
- Fréquemment rencontrées dans les services de médecine interne.
- Elles constituent un groupe très hétérogène de pathologies
- Présentation clinique : polymorphe
- Diagnostic étiologique : varié
- De gravité variable
- Traitement : étiologique

Physiopathologie

- Réaction macrophagique à un agent pathogène
 - Organique/non
 - Endogène/exogène
 - Connu/non
- Persistance dans les cellules phagocytaires et mise en place d'une immunité spécifique réponse adaptative
- Initiation d'une réponse Th1 (T helper)

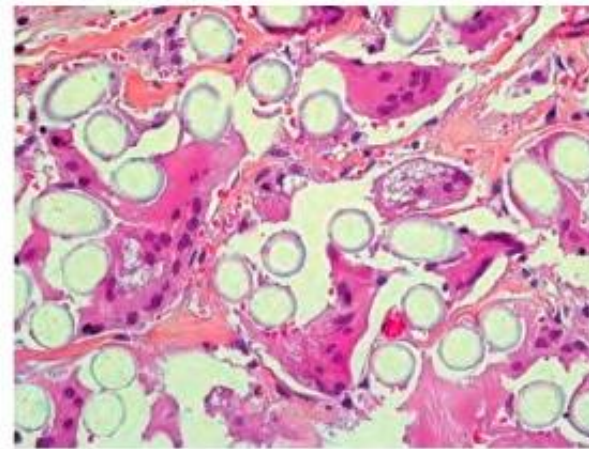
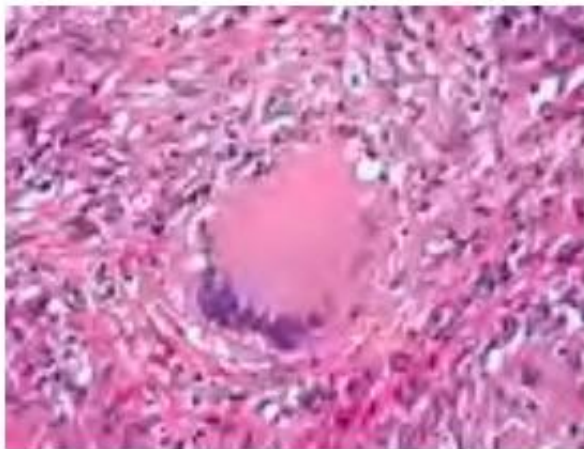
Anapath : granulome

- Agrégat de macrophages.
- Répartition épithélioïde:
 - Cellules de grande taille,
 - Cytoplasme abondant éosinophile
 - Agencement en palissade
- Peut contenir:
 - Nécrose
 - Lymphocytes, PNN, PNE
 - Plasmocytes, fibroblastes
 - Cellules géantes multi-nucléées
- Parfois entourée de fibrose

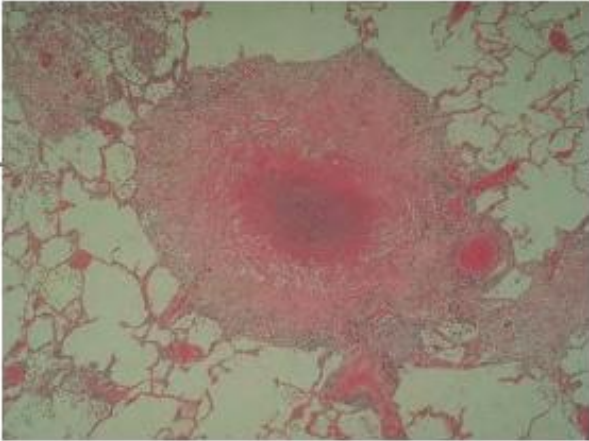
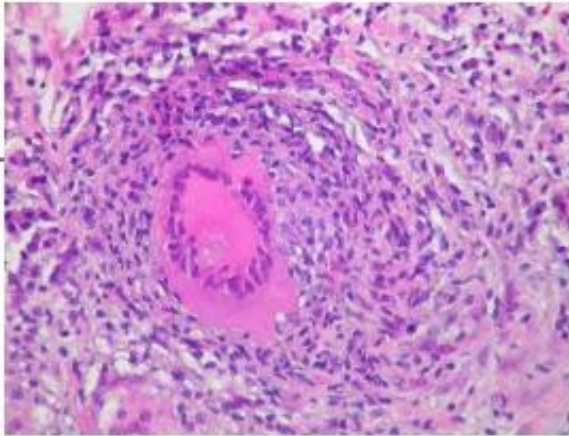


Cellules géantes

Cellule de Langhans	Cellule de Muller
Noyaux en périphérie, en fer à cheval	Noyaux très nombreux disposés « au hasard » dans le cytoplasme
Tuberculose, sarcoïdose, infections fongiques, ...	Corps étranger



Nécrose?

Nécrose	Pas de nécrose
Infection ++ Pneumonie d'inhalation Wegener PR <i>Sarcoïdose</i> 	Sarcoïdose PHS Hot Tub Lung <i>Infection</i> <i>LIP</i> 

Présentation clinique :

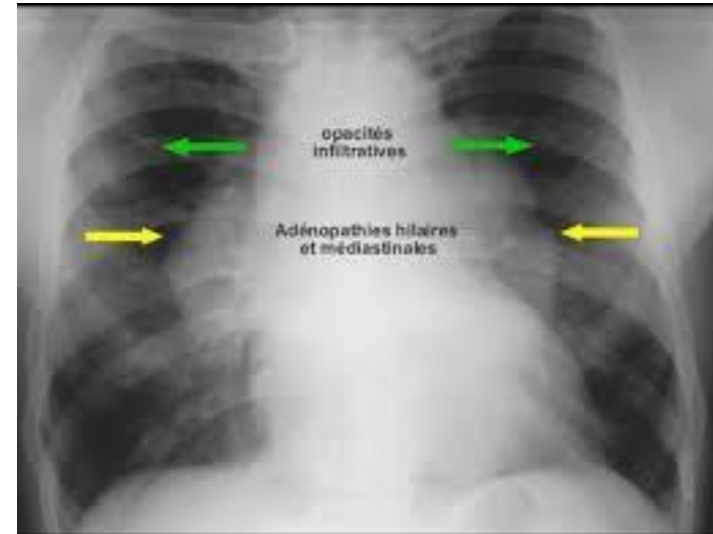
- Tous les organes peuvent être touchés

Atteinte médiastino-pulmonaires

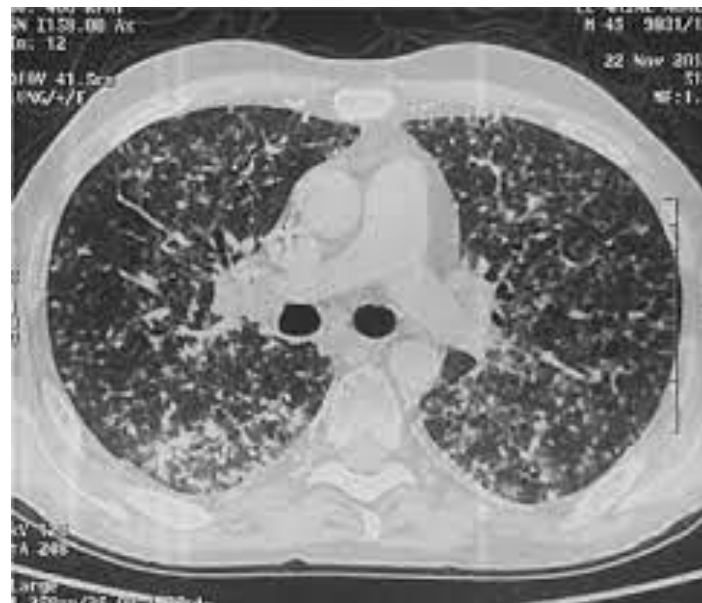
- *Les granulomes créent une perturbation des échanges gazeux.*
- *Ils peuvent conduire à des dommages tissulaires irréversibles dominés par une fibrose interstitielle diffuse.*



**Granulomatose avec polyangéite
(lésion pulmonaire)**



Adénopathies médiastinales



**Pneumopathie
interstitielle**

Atteinte ganglionnaire

- Tous les ganglions peuvent être atteints :
 - Superficiel ou profonds
 - Unique ou multiple

Atteinte hépatique

- Cytolyse
- Cholestase
- Hépatomégalie
- Cirrhose :
 - Foie dur
 - Insuffisance hépatocellulaires
 - HTP



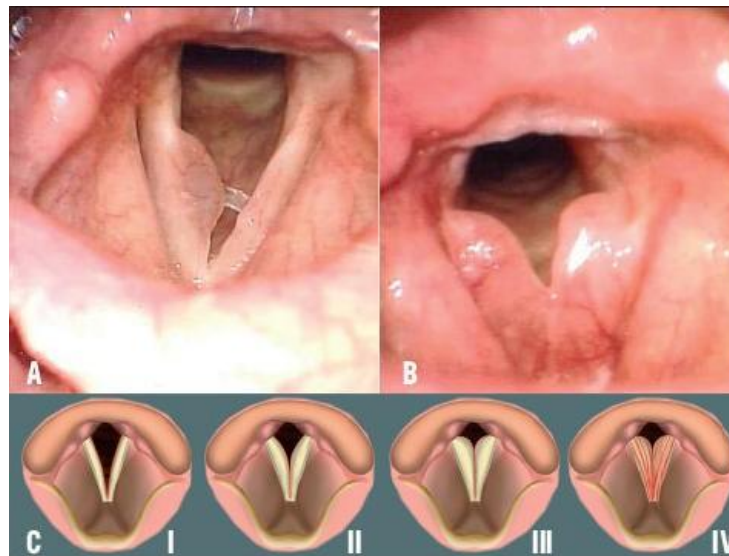
Atteinte cutanée



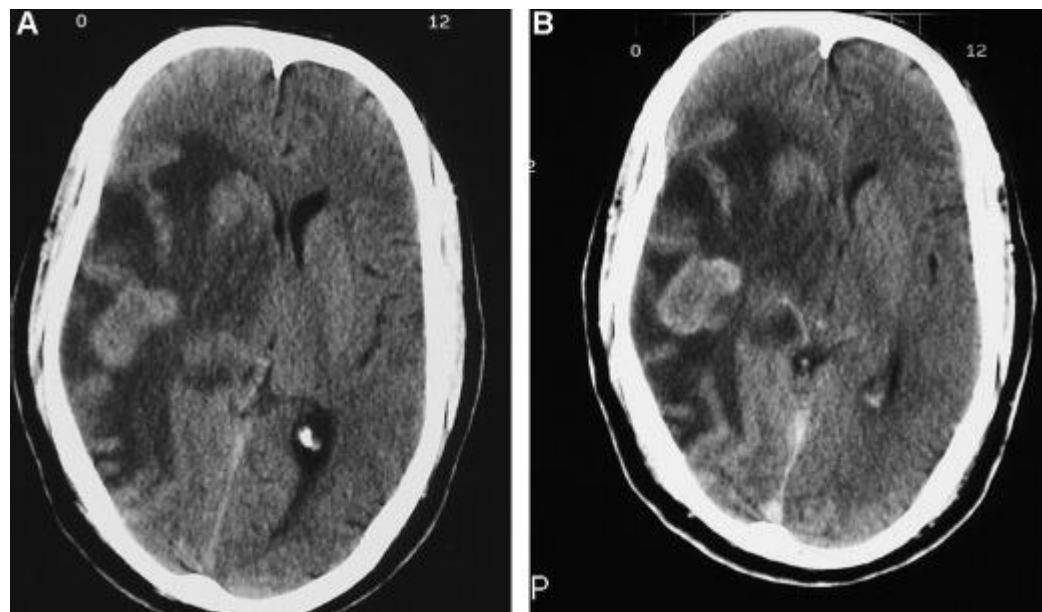
Localisation naso-pharyngée



Figure 1. A small, dark, fleshy growth on the left nostril.



Cérébrale



Cardiaque

Troubles de la conduction

++

+ Troubles du rythme

Myocardite

Syndromes coronaires

Les granulomatoses rénales (GR)

- Entités rares qui représentent 0,5 à 1,3 % des néphropathies documentées sur le plan histologique.
- Elles sont définies par la présence de granulomes au sein du parenchyme rénal, quel que soit leur nombre ou leur siège.

Granulomatose oculaire



Étiologies :

- Maladies inflammatoires systémiques
- Néoplasies
- Toxiques
- Déficit immunitaire
- Infectieuse
- Idiopathique

Maladies inflammatoires systémiques

- Sarcoidose
- Maladie d'HORTON
- Maladie de Takayachu
- Granulomatose avec polyangéite : Maladie de Wegener
- Périartérite noueuse
- Colite cryptogénétique (RCUH et maladie de Crohn)

Bactéries	Virus	Parasites	Champignons
Mycobactéries Tuberculose Mycobactéries atypiques Lèpre Autres Syphilis Listériose Salmonellose Donovanose Brucellose Pasteurellose Yersiniose Nocardiose Bartonellose Tularémie Whipple	VIH VHB, VHC EBV CMV	Bilharziose Toxocarose Toxoplasmose Leishmaniose	Candidose Aspergillose Cryptococcose Histoplasmose

Néoplasies¹⁵⁻¹⁸

- Lymphomes
 - cutanés : lymphomes T de type mycosis fongoïde (granulomateux)
 - systémiques : hodgkiniens, non hodgkiniens
- Syndromes myélodysplasiques
- Tumeurs solides : pulmonaire, sein, col de l'utérus, prostate

Toxiques

- Médicamenteux : antihypertenseurs, hypolipémiants¹⁹
- Immunothérapie et facteurs de croissance : interféron α , G-CSF, inhibiteurs du TNF- α
- Agents chimiques par réaction à corps étranger : béryllium, cérium²³

Déficits immunitaires²¹

- congénitaux, déficit immunitaire commun variable ou sévère, syndrome de Wiskott-Aldrich, granulomatose cutanée chronique
- acquis, iatrogènes

Idiopathique, diagnostic d'attente

Traitement

- Symptomatique
- Etiologique

Conclusion :

- Les granulomatoses systémiques sont des pathologies rare.
- Les manifestations cliniques sont très variés
- Les étiologies sont variées
- De diagnostic parfois difficile
- Le traitement dépend de l'étiologie

Merci pour votre attention